



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Oftalmología

¿Cuál de los siguientes datos NO es indicativo de aparición de una catarata?

1. Miopización.
2. Pérdida de AV.
3. Hipermetropización.
4. Leucocoria.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Cuando un paciente desarrolla una catarata, se produce una disminución progresiva de la agudeza visual, sin dolor ni inflamación. Suele mejorar en ambientes poco iluminados o tras instilar un midriático, y empeora en ambientes muy iluminados. En algunos pacientes, los síntomas comienzan con una mejoría de la presbicia, por un aumento en el índice de refracción del cristalino, ya que al formarse la catarata el cristalino aumenta de volumen y con ello aumenta el índice de refracción, miopizando al paciente. También pueden aparecer fotofobia, visión de halos coloreados y diplopía monocular (debidos a diferencias de refracción entre zonas de la lente).

-----o-----

Varón de 51 años sin patología oftalmológica previa, que presenta en los últimos meses dificultad para enfocar los objetos cercanos, siéndole de gran dificultad leer el periódico o un libro. En relación a la alteración que presenta dicho paciente, ¿cuál de las siguientes lentes usaría para corregirla?

1. Lentes convergentes.
2. Lentes cilíndricas.
3. Lentes divergentes.
4. No es posible corregirla con lentes, siendo la única opción terapéutica la cirugía refractiva.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso típico de presbicia. Esta se define como la pérdida de la capacidad de acomodación por disminución de la elasticidad del cristalino y por descenso de la fuerza contráctil del músculo ciliar. Se caracteriza por una incapacidad para enfocar los objetos cercanos y aparece generalmente a partir de los 40 años. Se corrige con lentes convergentes (al igual que la hipermetropía - respuesta 1 correcta -). Repasemos las demás opciones de respuesta:

2.- Las lentes cilíndricas se utilizan para corregir el astigmatismo.

3.- Las lentes divergentes se utilizan para corregir la miopía.

4.- La cirugía refractiva (la técnica LASIK es la más utilizada), se utiliza para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.

-----o-----

Mujer de 76 años que dos años antes fue intervenida quirúrgicamente y sin complicaciones de catarata en su ojo izquierdo. Refiere que desde hace unos meses tiene la sensación de que se le ha reproducido la catarata. Señale el diagnóstico MÁS

probable:

1. Catarata secundaria por extracción incompleta del cristalino.
2. Opacificación de la cápsula posterior.
3. Edema macular quístico.
4. Luxación de lente intraocular a la cavidad vítrea.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La complicación más frecuente de la cirugía de catarata es la opacificación de la cápsula posterior (respuesta 2 correcta). Esta complicación se produce habitualmente al cabo de dos o tres años y se debe a la proliferación de las células cristalinas que quedaron a nivel del ecuador. Estas células proliferan y migran al espacio comprendido entre la lente intraocular y la cápsula posterior. Aunque las mejoras en las técnicas de facoemulsificación, y de los materiales y el diseño de las lentes intraoculares han reducido su incidencia, lo cierto es que sigue siendo una complicación muy habitual. Afortunadamente se trata de forma sencilla realizando una capsulotomía con láser YAG (un pequeño orificio en la cápsula posterior para despejar el eje visual). La capsulotomía habitualmente devuelve al paciente la agudeza y la calidad visual previa.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes procedimientos podría usted realizar con un láser YAG?

1. Panfotocoagulación
2. Irididotomías
3. Cirugía refractiva
4. Cirugía de catarata

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Panfotocoagulación: Láser ARGÓN.

Cirugía refractiva: Láser EXCIMER.

Cirugía de catarata: SIN LÁSER. Con facoemulsificación (que emplea ultrasonidos) e implante de lente intraocular (LIO).

Recuerda que la capsulotomía también se realiza con láser YAG. La fotocoagulación local de los microaneurismas maculares para tratar un edema macular diabético extrafoveal también se haría con láser ARGON.

-----o-----

Paciente VIH positivo de 37 años de edad. Tiene un nivel muy bajo de linfocitos CD 4, porque no ha seguido la terapia antiretroviral que se le ha recomendado por problemas psiquiátricos. Acude refiriendo pérdida brusca de visión en ambos ojos. En el fondo de ojo se aprecian abundantes exudados y hemorragias. Con respecto al diagnóstico más probable, señale la correcta:

1. Retinitis por CMV.
2. Coroiditis por toxoplasma.

3. Uveítis posterior por Candida albicans.
4. Coroidopatía en perdigonada.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La retinitis por CMV es la causa más importante de uveítis posterior en pacientes inmunodeprimidos, como el que se nos presenta en este caso clínico. Recuerda que este virus produce una retinitis necrotizante y por ello es característica la aparición de múltiples exudados y hemorragias en el fondo de ojo. El tratamiento se realiza con ganciclovir, aunque la mejoría del estado inmunológico del paciente evitaría la recidiva.

-----O-----

Paciente diabético de 63 años, que acude a consulta tras haber sufrido un accidente de tráfico la semana anterior. El paciente le explica que tiene la sensación de que “algo no funciona en su vista” porque no vio aparecer el coche que venía por su derecha en el cruce. Al entrar en la consulta, curiosamente, el paciente ha tropezado con un mueble bajo. En la exploración, la agudeza visual sin corrección es de 1.0 en ambos ojos, y las pupilas son isocóricas. Las papilas, bien delimitadas, muestran una excavación de 0.7 en OD y de 0.8 en OI. La exploración de la visión cromática mediante test de Ishihara es normal. La sospecha diagnóstica en este paciente es:

1. Neuropatía óptica retrobulbar.
2. Glaucoma crónico simple.
3. Degeneración macular senil.
4. Miopía simple.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Estamos ante un paciente con clínica de pérdida de campo visual periférico y aumento de excavación papilar, rasgos típicos del glaucoma crónico simple. Aunque el factor de riesgo más importante es la hipertensión ocular, la edad y la diabetes son factores que aumentan la probabilidad de este diagnóstico. La no afectación de la agudeza visual excluye el resto de diagnósticos. Además, el defecto campimétrico típico es el escotoma central en la DMAE. En la miopía no tiene por qué existir pérdida de campo visual, salvo en aquellos casos en que se trate de una miopía degenerativa, en la que puede haber defectos en el campo visual relacionadas con la atrofia coriorretiniana; en estos casos pueden ser centrales + metamorfopsia (membrana neovascular miópica), o periféricos, relacionados con una atrofia retiniana periférica. Una neuritis retrobulbar tiene un inicio agudo.

-----O-----

Recién nacido de 2 meses de edad. La madre le comenta que prácticamente desde que nació le llora el ojo. De entre las siguientes opciones terapéuticas, ¿Cuál le parece MÁS apropiada?

1. Actitud expectante, recomendando masajes en el saco lacrimal.
2. Sondaje de la vía lacrimal programado.
3. Tratamiento intensivo con corticoide y antibiótico tópico.
4. Dacriocistorrinostomía.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La obstrucción congénita de la vía lacrimal es un problema muy frecuente en el recién nacido. Se debe a la presencia de una obstrucción en el tramo final del conducto nasolacrimal. Se sabe que muchos casos evolucionan de forma espontánea de un modo favorable. Por ello, en principio se toma una actitud expectante y solo si el problema persiste, se opta por el sondaje. El tratamiento tópico con antibióticos solo estaría indicado de forma puntual durante las fases de reinfección. La dacriocistorrinostomía consiste en realizar una osteotomía para posteriormente anastomosar el saco lacrimal y constituye el tratamiento de elección en los adultos. Sin embargo, en los niños es excepcional que sea necesaria, pues la mayor parte de los casos evolucionan de forma favorable espontáneamente o con el sondaje.

-----O-----

Mujer de 32 años que comenzó hace cinco días con el ojo izquierdo rojo y doloroso. Como no tenía tiempo para acudir al servicio de urgencias, se puso el colirio de tobramicina y dexametasona que le habían recetado a su hermana por una conjuntivitis. Desde hace dos días se encuentra peor y en urgencias la diagnostican de queratitis herpética. Señale la respuesta más probable:

1. Tiene una queratitis neuromparalítica.
2. Tiene una queratitis disciforme.
3. Tiene una úlcera geográfica.
4. Tiene una úlcera dendrítica infectada.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los corticoides agravan las queratitis herpéticas. Los herpes corneales comienzan como úlceras dendríticas que, si se dejan mucho tiempo o se instilan corticoides, se transforman en úlceras geográficas. Ambos tipos se tratan con aciclovir tópico. Las queratitis disciformes se producen por afectación estromal secundaria a varios brotes de queratoconjuntivitis herpética. Se trata con midriáticos y corticoides tópicos. Las queratitis neuromparalíticas se producen por lesión del trigémino porque la córnea pierde su inervación.

-----O-----

Respecto a la aniridia, señale la afirmación falsa

1. Se denomina aniridia a la ausencia congénita de iris
2. Las alteraciones que la producen se localizan en el gen PAX6
3. Se acompaña en muchos casos de hipoplasia foveal
4. No influye en el desarrollo de la agudeza visual del niño

Resp. Correcta: 4

Comentario: La aniridia se acompaña en muchos casos de hipoplasia foveal, catarata, patología corneal y nistagmus. Estos aspectos influyen en el desarrollo visual del niño y en muchas ocasiones condicionan que presente baja agudeza visual.

-----O-----

Acude a su consulta una mujer de 38 años, muy nerviosa, aquejada de visión doble binocular, de unas dos semanas de evolución. Asimismo, dice tener los párpados más abiertos desde hace un par de meses, con los ojos “como saltones”, y sensación de arenilla cada vez más frecuente. En la exploración detecta usted un exoftalmos de

predominio derecho, una disminución del menisco lagrimal, retracción palpebral bilateral y un estrabismo restrictivo con endotropía derecha y restricción a la abducción y supravversión en ambos ojos. Ante esta paciente, señale la opción FALSA:

1. La enfermedad que sufre la paciente es de origen autoinmune.
2. Está indicada la realización de una prueba de imagen para el estudio orbitario.
3. La lubricación, los corticoides y la radioterapia forman parte del abanico terapéutico en estos pacientes, pero no la cirugía.
4. Aunque en la mayoría de casos la afectación ocular es leve, en una minoría podemos llegar a ceguera por compresión de nervio óptico o exposición corneal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los pacientes con orbitopatía tiroidea asocian en muchas ocasiones sintomatología de hipertiroidismo como nerviosismo, taquicardia, fatiga, etc. aunque también puede aparecer en pacientes hipo o eutiroideos. La infiltración linfocitaria autoinmune de los tejidos orbitarios (músculos extraoculares, grasa y glándula lagrimal) conducen a un aumento de tamaño de los mismos, la presión orbitaria que dificulta el drenaje del humor acuoso subiendo la presión intraocular, y empujan hacia delante el ojo generando exoftalmos y retracción palpebral aumentada por la propia infiltración muscular con fibrosis secundaria. Si el paciente está hipertiroideo, además, la hipersensibilidad a catecolaminas aumenta la retracción palpebral superior por estimulación del músculo de Müller. En el TAC orbitario apreciaremos el engrosamiento de los vientres musculares de los músculos rectos por inflamación que genera en la relajación de los mismos y retracción, dando con ello estrabismos de tipo restrictivo, y afectando sobre todo a los músculos recto inferior y medial. En aquellos casos muy intensos, el exoftalmos es tan severo que el paciente no puede cerrar los ojos y pueden aparecer úlceras corneales por exposición que sean difíciles de curar y generen leucomas (pérdida de transparencia corneal). Si la congestión orbitaria es severa, puede verse comprimido el nervio óptico, generando una malfunción del mismo. Los casos más leves se tratan con lubricación para mitigar las molestias por sequedad ocular y exposición corneal, reservándose los corticoides y la radioterapia para casos en los que la inflamación sea muy intensa. La cirugía suele tener un papel rehabilitador (opción 3 falsa, por lo que la marcamos) en la corrección del exoftalmos, el estrabismo y/o la retracción palpebral, una vez superada la fase inflamatoria aguda que dura aproximadamente un año, aunque ocasionalmente se utiliza de forma más urgente en los casos de neuropatía óptica compresiva, luxaciones de globo espontáneas o queratitis severas por exposición.

-----O-----

Paciente que acude a quirófano para ser intervenido de catarata en su ojo derecho. En el mismo ojo presenta historia de uveítis anterior de repetición. Debido a ella, en la Historia Clínica se refleja la presencia de una dificultad de dilatación en ese ojo por la presencia de sinequias posteriores. Ante la mayor dificultad de la cirugía, se realiza una anestesia retrobulbar. Segundos después, usted aprecia que el ojo derecho presenta un exoftalmos respecto al izquierdo. Debe sospechar que:

1. Es un exoftalmos previo que había pasado inadvertido, se debe suspender la intervención y solicitar un TAC para estudiarla.
2. Es un exoftalmos previo que había pasado inadvertido, se puede realizar la intervención y estudiarlo posteriormente.
3. Puede ser un ojo miope previo, por eso sus ojos son más grandes que los normales.
4. El paciente presenta una hemorragia orbitaria.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La aparición de un exoftalmos brusco nos debe hacer pensar en una hemorragia orbitaria, que puede aparecer tras una inyección retrobulbar o bien tras el sangrado de una malformación vascular orbitaria.

-----O-----

Las úlceras neuroparalíticas se relacionan con lesiones de un par craneal. Señálelo:

1. III.
2. IV.
3. V.
4. VI.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La inervación sensitiva de la córnea corre a cargo del nervio trigémino. La desaferenciación sensitiva ante una lesión del trigémino genera una falta de trofismo corneal que genera úlceras no dolorosas de difícil resolución.

-----O-----

Antonio es miope de -8 dioptrías en ojo derecho y -12 en ojo izquierdo. Desde hace 2 días nota “una mosca” en ojo derecho. Al acostarse y apagar la luz ayer, veía una “lucecita”, pero no le dio importancia. Al despertar hoy percibe una “cortina negra” en su ojo derecho que ocupa el campo visual inferior. ¿Cual de las siguientes es cierta?

1. Su patología afecta a la retina inferior.
2. Podría haber evitado el quirófano mediante fotocoagulación con láser argón.
3. Es patología isquémica de nervio óptico
4. La miopía es un factor protector

Resp. Correcta: 2

Comentario: El paciente presenta un desprendimiento de retina regmatógeno superior (respuesta 1 y 3 falsas), que se produce a partir de un desgarro en la retina a través del cual pasa fluido al espacio subretiniano. Antes de que esto suceda, cuando solo hay desgarro, puede ser tratado mediante fotocoagulación con láser argón en consultas (respuesta 2 correcta), pero una vez producido el desprendimiento de la retina el tratamiento es quirúrgico. Una vez intervenida, la retina desprendida puede recuperar la visión perdida (respuesta 4 falsa).

-----O-----

El tumor orbitario más frecuente en el adulto es:

1. Hemangioma.
2. Quiste dermoide.
3. Rabdomiosarcoma.
4. Meningioma.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Del tema de los tumores de la órbita no es necesario que entres en mucho detalle, pero sí que te quedes con los datos clave. El hemangioma cavernoso es el tumor orbitario más frecuente en los adultos, es de carácter benigno y es la causa más frecuente de exoftalmía tumoral en el adulto. Es de predominio femenino y suele localizarse en el espacio graso posterior al globo ocular. Las opciones 2, 3 y 4 son tumores orbitarios típicos de la infancia. De ellos puedes recordar que el glioma del nervio óptico se asocia a la neurofibromatosis tipo I.

-----o-----

En la ptosis palpebral todo lo siguientes es cierto, EXCEPTO:

1. Habitualmente no produce más que alteraciones estéticas, a no ser que llegue a tapar la pupila.
2. La ptosis congénita puede ser causa de ambliopía.
3. Una de las causas es la lesión del III par craneal.
4. La parálisis del facial puede ser la etiología.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La ptosis no es un tema directamente muy preguntado, pero aparece como signo de otras patologías en numerosas preguntas. Lo más importante es conocer la innervación de la musculatura y qué músculo produce qué movimiento. Son elevadores del párpado el músculo de Müller (innervado por el simpático cervical) y el músculo elevador del párpado superior (innervado por el III par). La lesión de cualquiera de éstos produce ptosis. Por otro lado el músculo orbicular está innervado por el VII par y su lesión produce lagofthalmos (incapacidad para el cierre palpebral).

-----o-----

Respecto a las alteraciones iridianas que se producen en el contexto de las uveítis, señale la respuesta correcta:

1. Los nódulos iridianos de Koeppe aparecen en el reborde pupilar en algunos casos de uveítis granulomatosas
2. La atrofia iridiana en "rueda de carro" es típica de las uveítis de causa tuberculosa
3. Las sinequias anteriores son más frecuentes que las posteriores
4. Los nódulos iridianos de Busacca aparecen en el reborde pupilar al igual que los de Koeppe

Resp. Correcta: 1

Comentario: La atrofia iridiana en rueda de carro es típica de las uveítis herpéticas y no de las tuberculosas. Las sinequias posteriores o iridocristalinianas son más frecuentes que las anteriores o iridocorneales. Los nódulos de Busacca aparecen en el estroma iridiano, alejados del reborde pupilar y son típicos de la sarcoidosis. La primera opción es por tanto la correcta

-----o-----

Un paciente de 72 años consulta por irritación ocular y sensación de cuerpo extraño en ambos ojos. A la exploración se observa la presencia de pestañas que crecen desde los orificios de las glándulas de Meibomio, por detrás de la línea normal de pestañas. Respecto a esta alteración NO es correcto:

1. Se trata de un caso de triquiasis
2. Se debe a una proceso de metaplasia
3. Se relaciona con frecuencia con la blefaritis crónica

4. El nombre distiquiasis es correcto

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La distiquiasis se debe a una metaplasia de las células de las glándulas de Meibomio en folículos pilosos. Guarda relación con blefaritis crónica, lesiones químicas, síndrome de Stevens-Johnson y penfigoide cicatricial ocular

-----o-----

En los casos de uveítis anterior, a la exploración, solemos encontrar la pupila afecta:

1. Midriática arreactiva
2. Midriática pero reactiva
3. De tamaño normal pero con DPAR
4. Miótica

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En las uveítis anteriores, debido al dolor y al espasmo del músculo esfínter pupilar, solemos encontrar la pupila miótica. Esto predispone a la formación de sinequias posteriores, por lo que es recomendable insitlar una gota midriática para evitar la formación de estas sinequias.

-----o-----

¿Cual de las siguientes NO produce típicamente uveítis hipertensivas?

1. Síndrome de Possner- Schlosmann primario
2. VH simple
3. Espondilitis anquilosante
4. VH Zooster

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las uveitis normalmente bajan la presión intraocular. Sin embargo las de causa herpética son típicamente hipertensivas. El Síndrome de Possner es un tipo de uveitis hipertensiva de causa idiopática que se ha relacionado también con el CMV.

-----o-----

El reflejo luminoso está mediado por los fotorreceptores retinianos y consta de cuatro neuronas. La primera (sensorial), la segunda (internuncial), la tercera (motora preganglionar) y la cuarta (motora posganglionar). Esto es importante para la exploración clínica del reflejo pupilar aferente. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO se acompaña de un defecto pupilar aferente relativo?

1. Desprendimiento de retina.
2. Catarata.

3. Neuritis óptica.
4. Obstrucción de la vena central de la retina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta se nos describen de forma sucinta las distintas neuronas que componen la vía visual para a continuación preguntarnos por la entidad que no justificaría la aparición de un defecto pupilar aferente relativo (DPAR). El DPAR o pupila de Marcus Gunn aparece en aquellas enfermedades que afectan al tramo inicial de la vía visual (retina y nervio óptico). La opción incorrecta, es la número 2, porque la opacidad de los medios ópticos del ojo (hemovítreo o catarata) no justificaría este hallazgo.

El DPAR se explora iluminando de forma alterna las pupilas. Al iluminar el ojo sano las pupilas reaccionan, y sin embargo al pasar la linterna al ojo enfermo experimentan una dilatación paradójica. Este hecho se debe a que cesa el estímulo sobre el ojo sano que es lo que estaba manteniendo las pupilas contraídas. En esencia con esta maniobra exploratoria, lo que hacemos es comparar los reflejos directo (que está afectado) y consensual (que está conservado).

-----O-----

Respecto a las escleritis, señale la respuesta falsa:

1. Se trata de una enfermedad infrecuente que afecta a todo el espesor escleral.
2. En ningún caso supone una amenaza para la visión.
3. Tras la instilación de una gota de fenilefrina, es típico que el enrojecimiento no blanquee.
4. Puede producir un adelgazamiento escleral.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las escleritis son inflamaciones del espesor completo escleral. Suelen ser de carácter inflamatorio y tener relación con otras enfermedades inmunes sistémicas. Existen formas necrosantes de escleritis que pueden llevar a adelgazamiento escleral progresivo y perforación del globo ocular.

-----O-----

Ante una paciente mujer de 29 años de edad, que refiere pérdida de visión en su ojo derecho de forma brusca, y es diagnosticada de neuritis retrobulbar, todas las siguientes exploraciones serán normales, excepto:

1. Exploración del segmento anterior en la lámpara de hendidura.
2. Exploración del fondo de ojo.
3. Exploración de las pupilas.
4. Valoración de la motilidad ocular extrínseca.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las neuropatías se clasifican en dos grupos (anteriores y posteriores), en función de la porción del nervio óptico que se vea afectada. Cuando la neuropatía es posterior (o retrobulbar), el fondo de ojo es normal, y por ello la única exploración que permite determinar que lo referido por la paciente es cierto, es la exploración pupilar. La pupila del ojo afecto reaccionará peor a la luz, que la del ojo sano. Ésta menor reactividad se valora iluminando de forma alterna las pupilas, y recibe el nombre de defecto pupilar aferente

relativo (o pupila de Marcus-Gunn). Por ello la respuesta correcta es la tercera.

-----o-----

Un niño de 4 meses de edad es remitido por su pediatra porque presenta varias manchas café con leche. En la exploración debe prestar especial atención a la exploración del iris y buscar:

1. Hipocromía de iris.
2. Nódulos de Lisch.
3. Nódulos de Busacca.
4. Nódulos de Koeppe.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La presencia de manchas café con leche, nos hace sospechar que el paciente pueda padecer una neurofibromatosis tipo 1. En esta situación es obligado buscar otras manifestaciones de la enfermedad. Se considera criterio diagnóstico la presencia de nódulos de Lisch. Los nódulos de Lisch son hamartomas iridianos. Los nódulos de Busacca y Koeppe son nódulos inflamatorios y aparecen en las uveítis. La hipocromía de iris es una manifestación del síndrome de Horner congénito.

-----o-----

Paciente que acude a Urgencias por ojo rojo doloroso acompañado de déficit visual, miosis, efecto Tyndall y precipitados endoteliales. ¿Cuál sería el tratamiento CORRECTO para este paciente?

1. Oclusión y pomada antibiótica.
2. Midriáticos y corticoides locales.
3. Diuréticos osmóticos sistémicos y colirios betabloqueantes.
4. Antibiótico de amplio espectro en colirio instilado cada hora.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Ojo rojo en MIOSIS es una uveítis anterior aguda, a no ser que te den indicios para pensar en una úlcera corneal (trauma previo, tinción fluoresceína, etc.). Suelen hacernos distinguirlo del glaucoma agudo de ángulo estrecho, en que la pupila se encuentra en midriasis. El tratamiento de la uveítis consiste en corticoides tópicos para tratar la inflamación y midriáticos (colirio ciclopléjico normalmente) para dilatar la pupila, evitando así la formación de sinequias y el dolor (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Paciente diabética de 25 años de evolución. Refiere pérdida visual progresiva en los últimos meses. La exploración es la siguiente: AV OD 0,2; OI 0,4, catarata inicial en ambos ojos, PIO 19/18 mmHg. En el fondo de ojo presenta exudados duros en área macular en ambos ojos. Antes de decidir llevar a cabo cualquier medida terapéutica, estaría indicado completar la exploración con:

1. Ecografía ocular.

2. Tomografía óptica de coherencia macular.
3. Campo visual.
4. Topografía corneal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El edema macular es la causa más importante de pérdida visual en el paciente diabético. Se debe a la alteración de la permeabilidad vascular que va a conducir al acúmulo de líquido en la retina. Clásicamente se ha tratado con láser focal (fotocoagulando de forma selectiva los puntos de fuga). En la actualidad se ha difundido mucho el uso de los fármacos antiVEGF en el tratamiento de esta patología. Sin embargo antes de llevar a cabo cualquier maniobra terapéutica, está indicado confirmar el diagnóstico. En este sentido la OCT (tomografía de coherencia óptica) resulta de gran utilidad. Se trata de una técnica de bajo coste y no invasiva que permite obtener cortes con gran detalle histológico de las capas de la retina. Esta técnica permite cuantificar el espesor retiniano. Si se confirma que existe un aumento de espesor en el área macular, estará indicado un láser focal, una inyección de fármaco antiVEGF o la combinación de ambos.

-----O-----

Ante un paciente que presenta pérdida notable de agudeza visual en ojo derecho instaurada progresivamente desde hace 2 días y que mantiene un aceptable reflejo pupilar, le presencia en fondo de ojo de hemorragias masivas sugiere:

1. Oclusión de la arteria central de la retina.
2. Oclusión de la vena central de la retina.
3. Retinopatía diabética proliferativa con hemorragia vítrea.
4. Retinopatía hipertensiva.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El paciente presenta una clínica característica de la oclusión de la vena central de la retina, con hemorragias y exudados en territorio de la vena ocluida que posteriormente se van reabsorbiendo poco a poco. Descartamos que sea la arteria tanto por la progresividad del cuadro (la obstrucción de la arteria central de la retina da lugar a una pérdida de visión brusca, no progresiva) como por el fondo de ojo, además suele afectarse el reflejo pupilar en mayor medida. Las opciones 4 y 5 son fácilmente descartables puesto que el paciente no es ni hipertenso ni diabético. El desprendimiento regmatógeno cursa con una clínica y un fondo de ojo diferentes.

-----O-----

Niña de 4 años con agudeza visual en ojo derecho 1 y en ojo izquierdo 0,3, que en la refracción bajo cicloplejia presenta en ojo derecho 0 dioptrías de esfera y de cilindro y en ojo izquierdo -3 dioptrías de esfera. ¿Cuáles son los diagnósticos de este paciente?

1. Miopía en ambos ojos y ambliopía en ojo izquierdo
2. Miopía en ojo izquierdo y ambliopía en ojo izquierdo
3. Miopía en ojo izquierdo y ambliopía en ojo derecho
4. Miopía en ojo derecho y ambliopía en ambos ojos

Resp. Correcta: 2

Comentario: El paciente presenta emetropía en OD con visión de 1 y miopía de -3 dioptrías en ojo izquierdo con baja agudeza visual (0,3) por lo tanto tiene miopía en ojo izquierdo y ambliopía en ojo izquierdo por anisometropía.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes cuadros se acompaña en ocasiones de infiltrados corneales sobre la membrana de Bowman?:

1. Conjuntivitis alérgica.
2. Uveítis anterior aguda.
3. Conjuntivitis bacteriana.
4. Conjuntivitis por adenovirus.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los infiltrados corneales son acúmulos de células inflamatorias en el espesor corneal. Sólo en el caso de las queratoconjuntivitis epidémicas estos infiltrados están subepiteliales o, lo que es lo mismo, sobre la membrana de Bowman. En el caso de las uveítis anteriores se depositan sobre la membrana de Descemet, o lo que es lo mismo, subendoteliales. La queratoconjuntivitis epidémica está producida por los adenovirus. La afectación ocular es severa y no se acompaña de manifestaciones sistémicas importantes. Además de hiperemia, inyección conjuntival, secreción serosa, folículos y adenopatía preauricular, pueden aparecer edema palpebral, hemorragias petequiales en la conjuntiva y queratitis punteada superficial, que tiñe con fluoresceína. Evoluciona a la formación de opacidades subepiteliales que desaparecen con el tiempo. El tratamiento es sintomático, con compresas frías, un AINE en colirio y antibióticos para evitar la sobreinfección. No se usan colirios corticoides, salvo para las opacidades subepiteliales en el estadio final. Son muy importantes las medidas higiénicas, pues es muy contagiosa.

-----o-----

Respecto a la queratoconjuntivitis límbica superior es cierto que:

1. Se relaciona con el HLA B25
2. Suele ser unilateral
3. Es más frecuente en varones
4. Suele guardar relación con una afectación tiroidea

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Suele afectar a los dos ojos en mujeres de mediana edad, aproximadamente el 50% de ellas con función tiroidea anormal (por lo general hipertiroidismo). Se calcula que el 3% de los pacientes con oftalmopatía tiroidea sufren QLS.

-----o-----

Un paciente varón de 80 años es sometido a una cirugía de catarata. Al comenzar la cirugía, se observa cierta dificultad para la dilatación de la pupila. Aún así, se decide continuar con la operación, pero durante el transcurso de ésta, se va perdiendo la dilatación pupilar. Además, el estroma del iris comienza a herniarse por algunos puntos, lo que finalmente obliga a suspender la cirugía. ¿Cuál es la patología que presenta el paciente de base y qué fármaco ha ocasionado esta complicación durante la

cirugía?

1. Hiperplasia benigna de próstata en tratamiento con tamsulosina.
2. Cáncer de próstata en estadio avanzado en tratamiento con hormoterapia.
3. Hiperplasia benigna de próstata en tratamiento con finasteride.
4. Cáncer de próstata en estadio avanzado en tratamiento con quimioterapia sistémica.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico fácil y típico que relata en qué consiste un síndrome de iris flácido durante la cirugía de catarata. Esta complicación se puede producir en pacientes tratados con tamsulosina (α bloqueante) para la hiperplasia benigna de próstata (respuesta 1 correcta). Este fármaco inhibe los receptores α_1 de forma selectiva. Este receptor no se encuentra en los vasos sanguíneos, con lo que la ventaja de este fármaco es que evitamos el efecto secundario de hipotensión ortostática. Este receptor sí se encuentra en la uretra y vejiga urinaria, lo que también le confiere como ventaja una alta potencia. Sin embargo, este receptor también se encuentra en el iris, provocando que con su uso el iris se atrofie y se produzca el síndrome de iris flácido durante la cirugía de catarata. Este síndrome se manifiesta con una mala dilatación al inicio de la cirugía que se pierde durante el curso de la misma, y con un iris flácido que tiende a herniarse aumentando mucho el riesgo de complicaciones. El resto de fármacos: finasteride (inhibidor de la 5α reductasa), quimioterapia y hormonoterapia, no producen el síndrome del iris flácido (opciones 2, 3 y 4 incorrectas).

-----O-----

La catarata es probablemente la causa de leucocoria más frecuente en el niño. Señale la afirmación falsa:

1. Compromete la visión si es total, o central y de tamaño importante como para cubrir el área pupilar
2. Puede ir acompañada o no de otras anomalías oculares
3. No tiene tratamiento
4. Puede ser hereditaria. Aunque también existen otras causas como infecciones intrauterinas, síndromes cromosómicos, enfermedades metabólicas y renales

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Cuando la catarata está afectando al desarrollo visual del niño debe operarse cuanto antes. La cirugía es el primer paso para solucionar la falta de visión del ojo con catarata, pero no es suficiente. Después se debe iniciar el proceso de rehabilitación y recuperación visual. Generalmente se realiza mediante corrección óptica y parches. Se trata de recuperar el ojo vago del niño, este proceso durará años, normalmente toda su infancia.

-----O-----

La retinopatía diabética e hipertensiva comparten muchas manifestaciones. Sin embargo, uno de los siguientes signos es propio de la retinopatía hipertensiva y no de la retinopatía diabética

1. Exudados algodinosos
2. Exudados duros
3. Edema de papila

4. Edema macular

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La retinopatía diabética e hipertensiva comparten muchas manifestaciones. Sin embargo el edema de papila es propio de retinopatía hipertensiva y no de la retinopatía diabética. Recuerda que su aparición es propia del grado IV y pone de manifiesto la existencia de daño visceral.

-----O-----

No esperaría que fuese una complicación de una miopía magna:

1. Uveitis posterior.
2. Degeneración macular.
3. Degeneración retiniana.
4. Desprendimiento de retina.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta sencilla si recordamos las complicaciones típicas de la miopía magna. Un individuo con miopía superior a 5 ó 6 dioptrías está predispuesto a glaucoma crónico, cataratas precoces, desprendimiento de retina y maculopatía, por lo que es recomendable que sea sometido a revisiones periódicas. El glaucoma es de tipo crónico simple o pigmentario. La catarata aparece de forma precoz y su localización es sobre todo subcapsular posterior. El desprendimiento de retina se debe a degeneraciones periféricas vitreoretinianas. La maculopatía es más frecuente en mujeres adultas, con miopía superior a 10 dioptrías. La uveitis posterior es un proceso inflamatorio relacionado fundamentalmente con enfermedades sistémicas e infecciones (toxoplasma, histoplasma, citomegalovirus,...)

-----O-----

¿Cuál de estos fármacos puede desencadenar un glaucoma agudo de ángulo cerrado?

1. Pilocarpina.
2. Topiramato.
3. Dexametasona.
4. Eritromicina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El topiramato puede desencadenar miopía aguda y glaucoma de ángulo cerrado en algunos pacientes debido a una efusión coroidea.

La pilocarpina produce miosis y por ello se emplea en el tratamiento del glaucoma agudo de ángulo cerrado.

La dexametasona no provoca midriasis ni miosis. En algunos pacientes puede dar lugar a un aumento de la presión intraocular, sin bloquear el ángulo.

La eritromicina es un antibiótico macrólido que no afecta a la dilatación pupilar ni a la producción ni drenaje del humor acuoso.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la tomografía de coherencia óptica?

1. Se trata de una tecnología transpupilar invasiva que requiere la inyección de contraste endovenoso para la toma de imágenes
2. Todavía no es posible cuantificar la medida de la capa de fibras nerviosas de la retina con esta tecnología
3. Es una prueba imprescindible para el diagnóstico de catarata
4. El funcionamiento de la OCT es parecido al ecógrafo, pero la OCT usa luz en vez de onda acústica y tiene una resolución superior a la ecografía

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La OCT se basa en el principio de la interferometría y al igual que la ecografía se trata de una técnica de imagen no invasiva (Respuesta 1 falsa), pero su resolución es superior (Respuesta 4 correcta) y prácticamente podría equipararse a un corte histológico ya que es capaz de segmentar las diferentes capas analizadas incluida la capa de fibras nerviosas de la retina (Respuesta 2 falsa) y por ello su utilidad en el glaucoma. Para diagnosticar una catarata basta con la exploración en lámpara de hendidura (Respuesta 3 falsa)

-----o-----

Un paciente de 37 años presenta ojo rojo doloroso (unilateral), con fotofobia y disminución de la agudeza visual. La exploración nos muestra hiperemia ciliar y discoria. ¿Cuál es la etiología MÁS frecuente de esta patología?

1. Espondilitis anquilopoyética.
2. Lupus eritematoso sistémico.
3. Idiopática.
4. Traumática.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La primera etiología de uveítis anterior aguda es idiopática (respuesta 3 correcta), y la primera causa conocida es la espondilitis anquilosante.

-----o-----

Mujer de 78 años de edad. Acude al hospital por dolor localizado en el canto interno de su ojo derecho de 3 días de evolución. Desde hace muchos años le llora mucho ese ojo. Se le propuso cirugía, pero la paciente decidió no operarse porque le daba mucho miedo. De entre las siguientes opciones terapéuticas señale la que considere más

acertada:

1. Programar para dacriocistorrinectomía al día siguiente.
2. Tratamiento antibiótico sistémico, y unas semanas después llevar a cabo dacriocistorrinostomía.
3. Tratamiento antibiótico sistémico y dacriocistectomía.
4. Tan sólo tratamiento antibiótico tópico.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Se nos describe a una mujer con un brote de dacriocistitis aguda. La dacriocistitis aguda, como en este caso, afecta habitualmente a pacientes que sufrían previamente una dacriocistitis crónica. En primer lugar es necesario controlar la infección y posteriormente cuando el cuadro agudo infeccioso haya cedido, llevar a cabo un procedimiento quirúrgico para evitar nuevas infecciones en el futuro. Desde el punto de vista quirúrgico existen dos posibles planteamientos. La cirugía más sencilla recibe el nombre de dacriocistectomía, y consiste en extirpar el saco lacrimal, de este modo la paciente no presentará nuevas infecciones, sin embargo al quedar interrumpida la vía lacrimal, presentará epífora crónica. La opción más recomendable y que es la cirugía de elección en la obstrucción de vía lagrimal baja en los adultos recibe el nombre de dacriocistorrinectomía y consiste en practicar una osteotomía a la cual se anastomosa el saco lacrimal. Esta cirugía evita las infecciones y la epífora. Por ello la opción correcta es la 2.

-----O-----

Uno de los siguientes músculos NO es innervado por el tercer par craneal. Señálelo:

1. Oblicuo inferior.
2. Recto superior.
3. Oblicuo superior.
4. Elevador del párpado superior.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El tercer par craneal inerva a los músculos rectos interno, inferior y superior, al oblicuo menor, y al elevador del párpado superior. Además, proporciona la innervación parasimpática ocular al músculo ciliar (acomodación) y al esfínter pupilar (miosis). El oblicuo superior, en cambio, es innervado por el cuarto par craneal.

-----O-----

Entre los factores predisponentes para la aparición de una queratitis fúngica, NO se incluye:

1. Traumatismo previo por cuerpo extraño de origen vegetal.
2. Postoperatorio de cataratas.
3. Queratoplastia previa.
4. Uso de lentes de contacto.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los factores predisponentes comunes son enfermedad crónica de la superficie ocular, uso prolongado de corticoides tópicos (con frecuencia junto con un trasplante corneal previo), uso de lentes de contacto,

inmunodepresión sistémica y diabetes. Además, suele asociarse a traumatismo, a menudo relativamente menor, por plantas o herramientas de agricultura/jardinería. Es muy raro que una cirugía de cataratas se complique por una infección por hongos de la córnea (marcamos la opción de respuesta 2).

-----O-----

Ante un defecto campimétrico homónimo superior derecho, congruente y sin alteración de los reflejos pupilares, esperamos encontrar la lesión causal:

1. Cintilla óptica izquierda.
2. Radiación óptica temporal izquierda.
3. Radiación óptica parietal derecha.
4. Córtex occipital derecho.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los defectos homónimos son causados por lesiones retroquiasmáticas contralaterales. Como nos describen una cuadrantanopsia, deben estar afectadas las radiaciones. Puesto que el defecto es superior derecho, las radiaciones afectas deben ser las inferiores izquierdas. Puesto que está afectado un tramo posterior de la vía visual, el defecto es congruente y no hay afectación pupilar.

-----O-----

Paciente de 49 años, presenta midriasis y limitación para la aducción del ojo derecho conservándose la abducción del mismo. ¿Qué nervio estaría afectado?

1. III par craneal
2. IV par craneal
3. VI par craneal
4. Simpático ocular

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta sencilla sobre los pares craneales oculomotores. Si el paciente tiene midriasis habrá que sospechar en un III pc, que en parte del trayecto, se acompaña del parasimpático cuya afectación produce midriasis si existe compresión del mismo. El motor ocular común o III pc inerva todos los músculos extraoculares excepto el oblicuo mayor y el recto lateral por eso conservará la abducción de ese ojo.

-----O-----

Un paciente joven le consulta por un episodio de pérdida de la visión por un ojo y dolor en el mismo que se acentúa con los movimientos. La exploración del fondo de ojo es normal. ¿Cuál de los diagnósticos siguientes será el MÁS probable?

1. Desprendimiento de retina.
2. Glaucoma.
3. Neuritis retrobulbar.
4. Hipertensión intracraneal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Ante un cuadro de pérdida visual monocular con fondo de ojo normal, debe sospecharse que el paciente sufre una neuritis retrobulbar. Dado que la afectación se encuentra en el nervio óptico, y no en la retina, el fondo de ojo no tendrá alteraciones. La sospecha se confirmaría explorando las pupilas, demostrando de este modo un defecto pupilar aferente relativo. La neuritis retrobulbar afecta sobre todo a mujeres jóvenes, aunque en este caso se trata de un varón. Otro dato típico, también presente en este caso, es la presencia de dolor al movilizar el globo ocular.

-----O-----

Un paciente de 5 años consulta por pérdida de visión en un ojo, asociado a dolor periorbitario y edema palpebral. Presenta inyección y quemosis conjuntival, limitación de la motilidad ocular y proptosis. La temperatura es de 38°C y en la analítica destaca una leucocitosis con desviación izquierda. ¿Cuál es la etiología más frecuente de este cuadro en la infancia?:

1. Traumatismo periorbitario.
2. Bacteriemia.
3. Extensión de una sinusitis etmoidal.
4. Extensión de una dacriocistitis.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El cuadro clínico descrito en la pregunta no ofrece muchas dudas: se trata de una celulitis orbitaria. La etiología infecciosa de la misma suele proceder desde los senos paranasales, que en el caso de la infancia suele originarse en una sinusitis etmoidal. Los gérmenes más frecuentes son el *S. aureus*, el estreptococo y el *Haemophilus influenzae*. Requiere en su tratamiento el ingreso hospitalario y antibioterapia intravenosa.

-----O-----

El astigmatismo regular en el que sus dos focos se forman detrás de la retina se denomina:

1. Astigmatismo miópico simple.
2. Astigmatismo mixto.
3. Astigmatismo hipermetrópico compuesto.
4. Astigmatismo hipermetrópico simple.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta difícil en cuanto a la terminología, pero que por analogía con los términos más usados se puede aproximar la respuesta. El astigmatismo es la ametropía en la que el poder de refracción del ojo no es el mismo en todos los meridianos, formándose dos focos. Según la situación de estos focos respecto a la retina podemos clasificarlo. El término mixto sería un foco delante y otro detrás. El término miópico se referiría si ambos focos son anteriores a la retina (igual que en la miopía). En nuestro caso al ser ambos focos detrás, corresponde al término hipermetrópico. El término simple hace referencia a que uno de los focos está en la retina y compuesto si ninguno de ellos está sobre la misma. Por ello es un astigmatismo hipermetrópico compuesto.

-----O-----

Paciente de 32 años de edad, miope de 4 dioptrías y practicante de triatlón. Habitualmente usa gafas, pero cuando entrena y participa en las competiciones, usa lentes de contacto blandas. Acude por dolor y fotofobia de tres días de evolución. En la exploración de su ojo derecho se aprecia un área infiltrada de unos 3 mm de diámetro, y Tyndall muy intenso. En esta situación es importante descartar uno de los siguientes agentes etiológicos.

1. 1. Acanthamoeba
2. 2. Fusarium
3. 3. Pseudomonas
4. 4. Toxoplasma gondi

Resp. Correcta: 1

Comentario:

De cara a identificar el agente etiológico responsable de una queratitis, es importante tener en cuenta el perfil epidemiológico del sujeto que la sufre. Un traumatismo vegetal sería el antecedente típico de una queratitis fúngica. El absceso corneal bacteriano es una entidad frecuente en diabéticos. El uso de lentes de contacto aumenta el riesgo de sufrir una ulcera bacteriana. Sin embargo la combinación de uso de lentillas (sobre todo lentillas blandas) y contacto del ojo con agua dulce no clorada aumenta de forma muy significativa el riesgo de infección corneal por amebas. En el caso clínico no se nos dice explícitamente que se haya bañado, pero se nos da a entender porque se nos cuenta que practica triatlón. Se trata de queratitis que tienen muy mal pronóstico.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes defectos del campo visual nos orientaría a pensar en un glaucoma crónico de ángulo abierto?

1. Escotoma arciforme
2. Escotoma centro-cecal
3. Escotoma altitudinal superior
4. Escotoma altitudinal inferior

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los defectos en el campo visual en el glaucoma crónico de ángulo abierto suelen comenzar en la zona nasal, posteriormente suelen progresar con alta frecuencia a defectos arqueados o arciformes. Recuerda que la visión central se conserva hasta el final.

Escotoma centro-cecal tienes que relacionarlo con las neuritis ópticas. Y los defectos altitudinales con la neuropatía isquémica, siendo más frecuente el altitudinal inferior.

-----o-----

Una lesión a nivel del ganglio geniculado lateral dará lugar a:

1. Hemianopsia homónima contralateral y abolición del reflejo fotomotor en el ojo ipsilateral al ganglio dañado.
2. Hemianopsia homónima poco congruente con abolición del reflejo fotomotor en el ojo ipsilateral al

- ganglio dañado.
3. Cuadrantanopsia homónima superior.
 4. Hemianopsia homónima contralateral.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Puesto que la lesión se sitúa por detrás del quiasma, el defecto tiene que ser necesariamente bilateral y homónimo. Las cuadrantanopsias se producen como consecuencia de la lesión de las radiaciones ópticas contralaterales al lado lesionado, respuesta 3 incorrecta. La exploración de los reflejos pupilares también tiene valor a la hora de situar la lesión. Las fibras pupilares se separan del resto de la vía óptica a nivel de la cintilla, y por ello una lesión que afecte al ganglio geniculado no interrumpe este arco reflejo. Por eso el reflejo pupilar no estará abolido en ninguno de los ojos (respuestas 1 y 2 incorrectas).

-----o-----

Señale la respuesta INCORRECTA, de entre las siguientes, sobre las inflamaciones de los párpados:

1. La blefaritis crónica suele manifestarse con escozor y picor palpebral, junto con sensación de cuerpo extraño y discreta fotofobia.
2. En la blefaritis anterior podemos ver collaretes escamosos en la raíz de las pestañas.
3. En la forma crónica de la disfunción de glándulas de meibomio (DGM) el borde palpebral suele estar engrosado y con vasos telangectásicos.
4. El tratamiento en las formas crónicas de blefaritis incluye la aplicación de paños fríos y drenaje quirúrgico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La blefaritis crónica habitualmente se maneja con masajes con calor, higiene palpebral, lágrimas artificiales o geles lubricantes para aliviar el ojo seco secundarios, y en los casos más severos, se pueden utilizar antiinflamatorios tópicos (corticoides), y/o antibióticos locales o sistémicos (tetraciclinas). El frío local no suele ser efectivo en el tratamiento, y la cirugía se reserva para los chalaziones que no desaparecen de forma espontánea o generan síntomas, o para orzuelos abscesificados en los que se drena el contenido purulento si estos no fistulizan a piel de forma espontánea (cosa que con tratamiento local con calor y antibioterapia sistémica suele suceder).

-----o-----

Cual de las siguientes afirmaciones sobre el agujero macular le parece incorrecta:

1. La realización de un fondo de ojo es útil en su diagnóstico.
2. La realización de una tomografía de coherencia óptica también.
3. Genera un escotoma temporal a la mancha ciega.
4. Produce una importante pérdida de agudeza visual.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El escotoma producido estará en el centro del campo visual, y por lo tanto nasal a la mancha ciega (representación de la imagen proyectada sobre el nervio óptico). Tras diagnosticarlo por la clínica (pérdida de AV y escotoma central) y la funduscopia y confirmarlo mediante TCO (ver imagen en el

manual), puede estar indicada su corrección mediante vitrectomía, no teniendo papel aquí el uso de antiangiogénicos.

Paciente de 33 años de edad que acude a consulta por molestias en el ojo izquierdo. La paciente refiere febrícula desde el día anterior que se mantiene hoy. A la exploración destacan lesiones vesiculadas en el párpado y se aprecia una úlcera geográfica en el ojo derecho que se tiñe con fluoresceína. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. Para el tratamiento se deben utilizar ciclopléjicos.
2. Para el tratamiento se debe utilizar aciclovir tópico.
3. Para el tratamiento se deben utilizar corticoides tópicos.
4. Para el tratamiento se deben asociar antibióticos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El caso clínico se corresponde con una úlcera herpética (imagen dendrítica o geográfica) habitualmente producida por el VHS-1. Para el tratamiento se deben utilizar ciclopléjicos (midriáticos para relajar el esfínter y el músculo ciliar), antivirales tópicos (aciclovir) y antibióticos profilácticos para prevenir una sobreinfección bacteriana. Sin embargo, los corticoides están contraindicados (no confundir con la úlcera intersticial disciforme donde sí se pueden usar los corticoides).

Señale la relación INCORRECTA:

1. Absceso bacteriano corneal – portador de lentes de contacto.
2. Queratitis por lagofthalmos - parálisis del trigémino.
3. Queratitis disciforme – queratitis herpética de repetición.
4. Queratitis punteada – soldador.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Nos están relacionando cada patología con su agente etiológico. Los portadores de lentes de contacto tienen más riesgo de abscesos corneales por erosionar la córnea y mantener un cuerpo extraño sobre la misma. La queratitis por lagofthalmos se produce en parálisis del facial, no del trigémino (opción 2 incorrecta). La afectación del trigémino produce queratitis neuroparalítica o neurotrófica al perderse la sensibilidad corneal, y se ve en ocasiones en pacientes con queratitis herpéticas de repetición durante un período prolongado de tiempo. La queratitis disciforme es una afectación estromal que se produce tras varios episodios de dendritas epiteliales y se trata con corticoides y midriáticos.

Un paciente de 5 años padece una enfermedad rara. Presenta abundantes pecas en las mejillas y en los brazos, telangiectasias en el borde de los párpados y verrugas en el pecho y la espalda. La enfermedad que padece este paciente:

1. Se hereda de forma autosómica recesiva.
2. Se hereda de forma autosómica dominante.
3. Está ligada al cromosoma X.

4. No es hereditaria.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

RC:1. El paciente presenta un xerodorma pigmentoso, un raro trastorno hereditario autosómico recesivo que se caracteriza por lesiones cutáneas que predisponen a cáncer de piel. Se estudia más a fondo en dermatología.

-----O-----

Entre las aperturas u orificios de la órbita, figuran todas las siguientes, EXCEPTO:

1. Hendidura esfenoidal.
2. Escotadura supraorbitaria.
3. Agujero redondo mayor.
4. Hendidura esfenomaxilar.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta de dificultad media alta, pero que se puede intuir sabiendo los huesos que conforman la órbita y que dan nombre a sus distintos orificios. El agujero redondo mayor esta localizado en la base del cráneo y es atravesado por la segunda rama del trigémino en su camino al exterior del cráneo.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes parejas de síntomas o signos es típica de una hemorragia orbitaria?

1. Exoftalmos bilateral y simétrico subagudo
2. Exoftalmos unilateral súbito
3. Exoftalmos unilateral pulsátil con vasos episclerales ingurgitados
4. Exoftalmos unilateral en paciente febril

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Hay que sospechar hemorragia orbitaria ante un exoftalmos progresivo y brusco de inicio agudo, habitualmente en un paciente con alguno de los siguientes antecedentes: traumatismo, cirugía orbitaria reciente, cirugía ocular bajo anestesia retrobulbar o discrasia sanguínea severa (por ejemplo plaquetopenia severa). El diagnóstico es clínico, y el manejo debe ser urgente dados sus graves consecuencias, y consiste en realizar una cantotomía y cantolisis quirúrgica (liberar el tendón cantal lateral) para disminuir el efecto de síndrome compartimental orbitario por la sangre, que puede inducir una oclusión de arteria oftálmica o neuropatía óptica.

-----O-----

Una de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de la orbitopatía tiroidea es FALSA. Señálela:

1. La administración intravenosa de corticoides se ha mostrado más eficaz y más segura que la oral.
2. El tratamiento quirúrgico rehabilitador (si es preciso) debe hacerse de forma secuencial, primero

- descompresión orbitaria, después cirugía palpebral y por último cirugía de estrabismo.
3. La radioterapia es una alternativa en la fase inflamatoria.
 4. Es importante el cese del hábito tabáquico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El orden correcto en la cirugía rehabilitadora es: primero la descompresión si fuera precisa, en segundo lugar la cirugía de estrabismo si es necesaria y, por último, la cirugía de corrección de la posición palpebral si hace falta. La explicación es que la descompresión puede afectar al estrabismo y al párpado, y la cirugía del estrabismo a la posición palpebral, por lo que la cirugía de esta debe realizarse en último lugar.

-----O-----

Acuden unos padres con un niño de 9 meses a la consulta de oftalmología porque le han visto torcer hacia adentro el ojo derecho desde hace unos tres o cuatro meses. Señale la opción FALSA:

1. El epicanto es la causa más frecuente de pseudostrabismo convergente.
2. Si descubrimos una elevada hipermetropía y un test de cover alterado deberemos esperar hasta que el niño colabore para la graduación subjetiva antes de prescribirle corrección para que sea lo más exacta posible.
3. Cuando un niño tiene estrabismo, la etiología más frecuente son las alteraciones neuromusculares idiopáticas.
4. El test de Hirschberg nos ayuda a descartar falsos estrabismos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Para explorar el estrabismo en niños utilizamos el test de Hirschberg, que consiste en ver si los reflejos corneales producidos por iluminación están o no centrados en ambas córneas, en el centro de las pupilas. Para el test de la oclusión o cover test se necesita cierta cooperación por parte del paciente. Si al tapar un ojo, el otro no se mueve y viceversa, el niño no es estrábico (ortoforia). Si al tapar un ojo, el otro se mueve, tomando la fijación, el niño es estrábico (tropía). Si al tapar un ojo, éste pierde el paralelismo con el que está fijando (movimiento de refijación al desocluirlo), se trata de una heteroforia o estrabismo latente. Si la exploración oftalmológica anterior es normal se dice que es un pseudostrabismo convergente si presenta epicanto y divergente si tiene hipertelorismo. La causa más frecuente del estrabismo del niño son las alteraciones neuromusculares idiopáticas, que suponen el 60- 65%. Son alteraciones en los sistemas supranucleares que supuestamente controlan el paralelismo de los ojos. En segundo lugar están las causas acomodativas basadas en la sincinesia acomodación-convergencia. La hipermetropía es habitual en la infancia, sin embargo cuando la cifra de hipermetropía es elevada, se produce una excesiva acomodación, provocando una convergencia excesiva. Existen métodos como el autorrefractor o la esquiascopia para conocer aproximadamente la refracción en niños que no colaboran para graduación subjetiva. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible. El principal objetivo es una buena agudeza visual, previniendo o corrigiendo la ambliopía, si ésta existiese (oclusión). Por eso aunque sean bebés les pautamos la corrección para que su visión se desarrolle lo mejor posible. La segunda prioridad será un buen aspecto estético y una adecuada visión binocular. Es preciso corregir el defecto de refracción, pero si a pesar de esto persiste la desviación, hay que recurrir a la cirugía, una vez tratada la posible ambliopía.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la miopía?

1. El ojo miope suele ser más largo (aumento de longitud axial) que el ojo emétrope.
2. Existen miopías con longitud axial ocular normal.
3. El ojo miope siempre presenta alteraciones en el fondo de ojo.
4. En el ojo miope el punto focal de la imagen en el infinito cae por delante de la fovea.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El ojo miope con una miopía baja no siempre tiene alteraciones en la retina (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos). Cuando la longitud del ojo es muy grande se asocia a mayor grado de miopía y puede producirse un adelgazamiento de las distintas capas del ojo, que visualizaremos como cambios en el fondo de ojo. Esto suele ocurrir en miopías por encima de - 6D, es decir, en la miopía denominada magna o degenerativa.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes fármacos puede inducir aumento de tensión ocular?

1. Agonistas alfa adrenérgicos.
2. Corticoides.
3. Ácido acetilsalicílico.
4. Betabloqueantes selectivos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los betabloqueantes, selectivos o no, actúan disminuyendo la producción de humor acuoso. Hay que tener especial cautela con los no selectivos al utilizarlos en pacientes con insuficiencia cardíaca y bloqueo A- V, y sobre todo en broncopatas y asmáticos; en algunos casos también pueden causar impotencia y depresión. Los agonistas alfa 2 adrenérgicos (como la brimonidina o apraclonidina) son hipotensores oculares muy eficaces. Sin embargo son frecuentes las alergias. Actúan disminuyendo la producción de acuoso en los procesos ciliares. Los corticoides, tanto con uso tópico, como oral o en inhalaciones, pueden producir elevación de la presión intraocular y catarata subcapsular posterior.

-----O-----

Una paciente de 68 años, diabética tipo 2 en tratamiento con insulina desde hace 4 años, consulta por una pérdida repentina de visión en el ojo derecho. La agudeza visual es de un 20%, cuando el mes pasado (última revisión) era de casi un 100%. No tiene dolor. El segmento anterior del ojo es normal. Teniendo en cuenta la causa más probable de su pérdida visual, señale la actitud inicial:

1. Colirios mióticos e hipotensores oculares.
2. Observación.
3. Vitrectomía.
4. Triamcinolona intravítrea.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Es una pregunta sencilla sobre un tema muy preguntado. Ante un diabético que presenta una pérdida de

visión brusca e indolora, lo que debemos sospechar es una hemorragia vítrea (hemovítreo). El tratamiento de esta será en primer lugar la observación, ingesta de abundantes líquidos y posición semisentada para dormir (a 45°). Y si se resuelve el cuadro, iniciaremos una panfotocoagulación con laser argón. Si el cuadro no se resuelve con la mera observación, nos vemos obligados a realizar la vitrectomía, pero no de entrada.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes patologías considera MÁS IMPROBABLE en una paciente que refiere pérdida visual en su OD, y presenta un defecto pupilar aferente relativo en dicho ojo?

1. Obstrucción de arteria central de la retina.
2. Neuropatía óptica isquémica.
3. Neuritis retrobulbar.
4. Catarata.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La presencia de un defecto pupilar aferente relativo (DPAR, o pupila de Marcus Gunn), es propia de una patología de la vía visual anterior (nervio óptico y retina). El defecto pupilar aferente relativo se explora iluminando las pupilas de forma alterna. Al pasar a iluminar el lado enfermo, las pupilas experimentarán una dilatación paradójica. El DPAR es propio de las neuropatías, pero también la patología retiniana cuando es severa puede producirlo. Sin embargo una catarata por densa que sea, no es capaz de producir un DPAR significativo. Por ello la opción incorrecta es la 4, y es la que marcamos.

-----O-----

Mujer de 56 años, que acude a Urgencias refiriendo pérdida de visión repentina. Tanto el fondo de ojo como la exploración con la lámpara de hendidura son normales. La evaluación campimétrica revela un defecto de los campos visuales nasal izquierdo y temporal derecho de poca congruencia. Pupilas anisocóricas, con un reflejo fotomotor ausente al iluminar las retinas temporal izquierda y nasal derecha. ¿Cuál es la localización MÁS probable de la lesión?

1. Cintilla óptica izquierda, probablemente por un ACV.
2. Radiaciones ópticas izquierdas, probablemente por un ACV.
3. Quiasma óptico inferior, probablemente por un adenoma hipofisario.
4. Nervio óptico, probablemente por un primer brote de esclerosis múltiple.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La descripción de la alteración campimétrica es la de un defecto homónimo de origen izquierdo. Si a esto le sumas la poca congruencia, que nos dice que el defecto es más central o anterior que posterior, y sobre todo la alteración pupilar, nos queda una única opción de respuesta posible que es la cintilla óptica izquierda (respuesta 1 correcta). La alteración pupilar se explica por el hecho de que el reflejo fotomotor simpático pasa por el nervio óptico y la cintilla en su camino a los núcleos de Edinger-Westphal del mesencéfalo. Posteriormente en los núcleos pretectales del mesencéfalo la vía se hace bilateral, y se encamina hacia la musculatura ciliar; esta alteración pupilar se denomina “pupila hemianópsica de Wernicke”. Recuerda también que un defecto campimétrico es más congruente, es decir, más parecido entre ambos ojos, cuanto

más posterior es. El defecto menos congruente es la neuritis óptica, y el defecto más congruente es la afectación de la corteza occipital.

Uno de los siguientes signos NO es típico de las uveítis anteriores agudas:

1. Células inflamatorias en cámara anterior
2. Proteínas en cámara anterior
3. Midriasis media
4. Hipopion

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El cuadro de la uveítis anterior aguda es un ojo rojo doloroso acompañado de fotofobia y miosis (no midriasis, que sería típico del glaucoma agudo). A la exploración veremos hiperemia ciliar o mixta, depósitos retrocorneales (sobre el endotelio), células en cámara anterior (Tyndall), puede haber proteínas en cámara anterior (flare), y si las células acabasen precipitando, formarían un nivel de hipopion. Podemos encontrarnos con sinequias anteriores (iris-córnea) o posteriores (iris-cristalino, más frecuentes).

Paciente que refiere desde hace tres días sensación de cuerpo extraño, legañas y secreciones en ambos ojos. Ha notado además la aparición de un bulto justo delante de su oreja derecha. Desde el punto de vista exploratorio, la AV es 1 en ambos ojos y presenta una inyección mixta intensa, así como folículos en la conjuntiva tarsal inferior. Señale cuál es el diagnóstico MÁS probable:

1. Conjuntivitis alérgica.
2. Conjuntivitis vírica.
3. Uveítis incipiente.
4. Queratitis herpética.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La ausencia de dolor descarta de entrada un ojo rojo grave. Desde el punto de vista exploratorio la AV conservada y la presencia de una inyección mixta, con secreciones y folículos confirman el diagnóstico de conjuntivitis. De cara al diagnóstico diferencial de las conjuntivitis, debes recordar que la sensación de cuerpo extraño, y la presencia de folículos y de una adenopatía preauricular es muy típica de las conjuntivitis víricas. En caso de presentar el paciente una conjuntivitis alérgica, la adenopatía preauricular estaría ausente, el paciente presentaría papilas y el síntoma predominante sería el picor. La opción 4 es incorrecta ya que, si presentara queratitis herpética, el caso clínico sería ojo rojo, doloroso, con úlcera corneal lineal con prolongaciones dendríticas o pseudodendríticas +/- vesículas en los párpados (si tuviera asociado blefaroconjuntivitis). La opción 3 también es incorrecta, ya que una uveítis daría ojo rojo, doloroso, y Tyndall en cámara anterior.

Uno de los siguientes signos oftalmológicos no nos hace pensar que en un paciente

postoperado de catarata se está produciendo una endoftalmitis infecciosa.

1. Ojo rojo
2. Hipopion
3. Exoftalmos
4. Edema corneal

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La endoftalmitis infecciosa es la complicación más grave tras la cirugía de catarata, afortunadamente poco frecuente.

Los síntomas son la disminución de visión de instauración brusca y dolor ocular creciente en un paciente que ha sido sometido a una cirugía intraocular.

Los signos característicos incluyen: congestión conjuntival y quemosis, edema palpebral, edema corneal, hipopion, fibrina y reacción intensa en cámara anterior, células y turbidez vítrea así como disminución del reflejo rojo.

El exoftalmos no lo relacionamos con la endoftalmitis infecciosa tras una cirugía intraocular, sino sobretudo con la celulitis orbitaria en el niño y la oftalmopatía tiroidea en el adulto.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes lesiones funduscópicas NO aparece en la trombosis de la vena central de la retina?:

1. Edema retiniano.
2. Venas ingurgitadas y tortuosas.
3. Mancha rojo cereza.
4. Exudados algodonosos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La mancha rojo cereza es un signo TÍPICO que aparece en el fondo de ojo en el curso de una obstrucción de la arteria central de la retina. La mácula aparece roja, al estar irrigada por la coriocapilar, mientras que el resto de la retina aparece blanquecina por la ausencia de irrigación. El resto de opciones sí que se corresponde con los signos oftalmoscópicos asociados a la trombosis de la vena central de la retina.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes es un signo de mal pronóstico después de una cirugía de la catarata?

1. El paciente no es capaz de ver de cerca
2. El paciente describe sensación de flashes y luces cuando apaga la luz
3. El paciente cuenta que tiene sensación de brillos por los lados
4. Sensación de roce, sequedad y cuerpo extraño

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La presbicia, los brillos y la sensación de sequedad son habituales. Los fosfenos pueden suponer el inicio de un desprendimiento de retina.

Señale el orden correcto de los pasos de la cirugía de la catarata:

1. Incisión corneal, capsulorrexis, aspiración del córtex, facoemulsificación del núcleo y el epinúcleo, implante de lente intraocular (LIO).
2. Incisión corneal, aspiración del córtex, capsulorrexis, facoemulsificación del núcleo y el epinúcleo, implante de lente intraocular (LIO).
3. Capsulorrexis, incision corneal, aspiración del cortex, facoemulsificación del nucleo y el epinucleo, implante de lente intraocular (LIO).
4. Incision corneal, capsulorrexis, facoemulsificación del nucleo y el epinucleo, aspiración del cortex, implante de lente intraocular (LIO).

Resp. Correcta: 4

Comentario: El orden correcto de los pasos de la cirugía de la catarata es el de la respuesta 4.

Paciente de 65 años con miodesopsias que evolucionan al cabo de 24 horas a pérdida visual en el hemicampo superior en el ojo derecho. ¿Cual es el diagnóstico más probable?:

1. Trombosis de rama venosa temporal superior de ojo derecho.
2. Embolia de arteria temporal inferior de ojo derecho.
3. Desprendimiento de vítreo posterior seguido de desgarro y desprendimiento retiniano.
4. Hemorragia macular hipertensiva

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las miodesopsias son la clínica típica del desprendimiento de vítreo posterior. Aunque suele ser benigno, en un 10- 15% de los casos pueden producirse tracciones vítreo- retinianas periféricas que pueden provocar hemorragias y desgarros periféricos en la retina que pueden predisponer al desprendimiento de la misma. El mecanismo de dicho desprendimiento es regmatógeno y su clínica es compatible con la evolución de nuestro paciente.

¿Cuál de los siguientes tumores palpebrales malignos tiene mejor pronóstico evolutivo?:

1. Carcinoma basocelular.
2. Carcinoma espinocelular.
3. Adenocarcinoma.
4. Melanoma.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los tumores palpebrales es un tema poco preguntado, del cual debes recordar que el carcinoma basocelular representa el 90% de los tumores malignos del párpado y que a pesar de su comportamiento agresivo local tiene un crecimiento muy lento y no da metástasis. En cuanto al espinocelular es mucho

menos frecuente (5%) y aunque su aspecto puede ser parecido puede dar metástasis y es más radiorresistente, por lo que tiene peor pronóstico. Frente a éstos el tumor palpebral maligno de peor pronóstico es el melanoma, como en cualquier otra localización pues son tumores muy metastizantes y de pronóstico grave.

-----O-----

Cual de las siguientes afirmaciones sobre la catarata senil es falsa:

1. La catarata senil produce una pérdida visual o visión borrosa lentamente progresiva, habitualmente a lo largo de meses o años.
2. Puede afectar a uno o ambos ojos.
3. Pueden producirse deslumbramientos, particularmente con las luces de los faros de los coches que se aproximan al conducir por la noche.
4. Nunca producen una disminución de la percepción del color.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La catarata senil al ser una opacificación progresiva del núcleo del cristalino produce una pérdida progresiva lenta de agudeza visual, que puede afectar a uno o ambos ojos, es frecuente que el paciente manifieste deslumbramientos sobretodo con las luces y de predominio por la noche, y también puede producirse una disminución de la percepción de los colores, aunque no con la misma intensidad que en las neuropatías ópticas.

-----O-----

Un paciente miope de -6 dioptrías, delineante y con cuarenta y seis años de edad, se queja de astenopía creciente durante las horas de trabajo. Descartada otra causa, se valora su presbicia en +1,25 dioptrías. La prescripción más correcta será:

1. Visión lejana -6 dioptrías. Visión próxima +1,25 dioptrías.
2. Visión lejana -7,25 dioptrías. Visión próxima +1,25 dioptrías.
3. Visión lejana -7,25 dioptrías. Visión próxima -4,75 dioptrías.
4. Visión lejana -6 dioptrías. Visión próxima -4,75 dioptrías.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla si analizamos el problema de nuestro paciente. Nuestro paciente para la visión lejana tiene un problema de -6 D al ser miope por lo que la corrección se debe realizar con -6 D.

Sin embargo al hacer uso de la visión cercana, el paciente a parte de sus -6 D de miope, tiene un defecto de acomodación de +1.25 D que le viene dada por la pérdida de la capacidad para acomodar de su cristalino (que sí se usa en la visión cercana y no en la lejana).

Por lo que la corrección la visión cercana debe ser de -4.75 D (suma de ambas potencias ópticas). Date cuenta de que corrigiendo algo menos la miopía en sus gafas de cerca, el paciente queda levemente miope y tiene que acomodar menos, y por ello verá mejor de cerca.

-----O-----

Paciente varón de 67 años que hace 4 meses fue diagnosticado de glaucoma crónico simple y se instauró el tratamiento correspondiente. Actualmente se queja de que sus pestañas han aumentado de tamaño siéndole muy molesto. ¿Cuál de los siguientes fármacos está tomando con mayor probabilidad?

1. Latanoprost.
2. Timolol.
3. Brimonidina.
4. Dorzolamida.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El latanoprost, bimatoprost y travoprost son análogos de las prostaglandinas F2 empleado en el tratamiento del glaucoma crónico simple. Son fármacos de primera línea por su alta eficacia y buena tolerancia sistémica. A nivel ocular, producen hiperpigmentación del iris, hiperemia y aumento del tamaño de las pestañas (CORRECTA 1).

El timolol es un b-bloqueante, la brimonidina es un agonista α -2 adrenérgico y la dorzolamida un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Todos estos son fármacos empleados en el tratamiento del glaucoma crónico simple, ninguno de ellos produce un aumento de tamaño de las pestañas.

-----o-----

Ante un único episodio de uveítis anterior aguda secundaria a un traumatismo (iritis traumática), señale la respuesta falsa:

1. Puede producirse fotofobia temporalmente
2. Puede aparecer cierto grado de hipema por sangrado uveal anterior leve postraumático
3. La agudeza visual suele recuperarse tras el tratamiento
4. Se produce una catarata postraumática en el 95% de los casos.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las iritis traumáticas o uveítis anteriores agudas postraumáticas son inflamaciones intraoculares secundarias a traumatismos oculares cerrados. Son muy típicas de los deportes de raqueta por traumatismos con la pelota. Aunque la catarata es una potencial complicación en un traumatismo contuso, su frecuencia es baja. El resto de las repuestas son correctas.

-----o-----

Acude a urgencias de Oftalmología un varón de 78 años con retinopatía diabética conocida por pérdida total y súbita de la agudeza visual en su ojo izquierdo. A la exploración, se objetiva una pérdida de fulgor pupilar al iluminar el ojo izquierdo. El paciente está muy angustiado, y nos pregunta en qué consiste el tratamiento de lo que él presenta. Intentamos explorar el fondo de ojo, sin éxito alguno, pues no somos capaces de ver el tejido retiniano. Realizamos una ecografía ocular, que nos descarta desprendimiento de retina. ¿Qué le explicaremos al paciente?

1. Se ha de intervenir quirúrgicamente lo antes posible.
2. Inicialmente, realizar seguimiento con actitud terapéutica conservadora.
3. Realizar inyección de antiVEGF intravítreo de forma urgente.
4. Realizar panfotocoagulación el mismo día o en los próximos días.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El paciente ha presentado una hemorragia vítrea, o hemovítreo, debido a una muy probable retinopatía diabética proliferativa. Han aparecido neovasos retinianos anómalos, que al ser más frágiles, han sangrado en la cavidad vítrea. No está indicada la vitrectomía urgente, ya que la sangre en muchos casos, la sangre se reabsorbe de forma espontánea y progresiva. Le explicaremos, además, que el descanso nocturno a 45° facilita su reabsorción.

La panfotocoagulación se realizará cuando la hemorragia vítrea se haya resuelto, ya que antes es técnicamente imposible realizar la técnica, puesto que la sangre impide la visualización de la retina y el paso de la luz del láser.

Los antiVEGF se utilizan en el edema macular diabético, no en la hemorragia vítrea.

-----o-----
Una pérdida de visión indolora unilateral de menos de un día de evolución puede ser producida por todas, EXCEPTO una de las siguientes:

1. Una neuritis óptica posterior.
2. Una oclusión de arteria central de la retina.
3. Un hemovítreo.
4. Un desprendimiento de retina regmatógeno.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Todas las patologías previas cursan con pérdida de visión indolora en el ojo afecto; sin embargo tanto la OACR, como el hemovítreo o en DR regmatógeno son indoloras, mientras que en la neuritis óptica posterior o retrobulbar esta inflamado el nervio óptico, por lo que el paciente refiere dolor que aumenta con los movimientos oculares.

-----o-----
Con respecto a la DMAE, señale la FALSA:

1. Cuando hay desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario, hay que descartar una membrana neovascular.
2. Hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas distrofias retinianas.
3. Hay que hacer diagnóstico diferencial con los estadios iniciales de la retinosis pigmentaria.
4. En las fases mas precoces de la enfermedad no hay que hacer tratamiento.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La retinosis pigmentaria es un tipo de distrofia periférica, con lo cual es difícil confundirla con una DMAE, cuya afectación es central. Cualquier afectación central o macular, como algunas distrofias retinianas, puede aparecer en el diagnóstico diferencial.

En las fases precoces de la enfermedad, así como en la DMAE seca , no hay tratamiento. Recordad que es útil una dieta rica en Vitaminas B, luteína y zeaxantina.

Paciente diabético de 10 años de evolución que presenta visión borrosa en ojo izquierdo de 3 meses de evolución, indolora y que apareció de forma gradual. En el fondo de ojo presenta microaneurismas en polo posterior con exudación lipídica asociada. Sobre el tratamiento de este paciente es cierto que puede ser útil todo lo siguiente excepto:

1. Los antiangiogénicos intravítreos.
2. El láser focal argón.
3. La panfotocoagulación argón.
4. Los corticoides intravítreos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El edema macular es la causa más frecuente de pérdida de visión en la retinopatía diabética. En casos de edema focal esta indicada la fotocoagulación selectiva (láser focal) de los puntos de fuga, mientras que en el edema difuso pueden ser útiles tanto los corticoides como los antiangiogénicos por vía intravítrea. En determinados pacientes la combinación de cualquiera de esos fármacos intravítreos seguido de fotocoagulación focal mejora los resultados. La panfotocoagulación retiniana en cambio, no es tratamiento del edema macular, sino de la retinopatía diabética proliferativa (definida por la presencia de neovasos).

Entre las medidas más habitualmente empleadas para el tratamiento del ojo seco NO se encuentra:

1. Lágrimas artificiales con ácido hialurónico
2. Dacriocistorrinostomía
3. Oclusión quirúrgica de los puntos lagrimales
4. Inmunosupresores tópicos (corticoides o ciclosporina)

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La primera línea de tratamiento en el ojo seco es el uso de lágrimas artificiales. Según la etiología del ojo seco pueden emplearse colirios inmunosupresores o inmunomoduladores tópicos como los corticoides o la ciclosporina de forma asociados. La “cirugía” del ojo seco en caso de realizarse sería la oclusión (cauterización, o parche conjuntival) de los puntos lagrimales (o más raramente escisión parcial de la glándula lagrimal principal), pero no la dacriocistorrinostomía, que se reserva para los casos de obstrucción de la vía lagrimal inferior o dacriocistitis crónicas.

¿Cuál de las siguientes alteraciones NO es frecuente encontrar en un paciente con papiledema?

1. Cefalea.
2. Deterioro del nivel de conciencia.
3. Parálisis del VI par.

4. Pupila de Marcus Gunn.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El papiledema se debe a una elevación de la presión intracraneal y afecta poco a la función visual en fases iniciales, por lo que de forma típica no se suele producir afectación del reflejo pupilar. Además, como la afectación es bilateral sería muy improbable que el paciente presentara un defecto pupilar aferente relativo (pupila de Marcus Gunn) (marcamos la opción de respuesta 4). La parálisis del VI par se debe, entre otras causas, a un efecto de compresión del nervio secundario a la elevación de la presión intracraneal. Es frecuente encontrar cefalea, deterioro del nivel de conciencia y diplopía.

-----O-----

Una Unidad de UCI neonatal pone una interconsulta al servicio de oftalmología para examinar a un recién nacido a la semana 31 de edad gestacional, con bajo peso y que presentó graves problemas respiratorios durante el parto. ¿Qué patología deberá descartar el oftalmólogo?

1. Retinoblastoma.
2. Persistencia primaria de vítreo hiperplásico.
3. Fibroplasia retrolental.
4. Catarata congénita.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Ante la descripción dada del paciente en la pregunta, la principal patología que se debe sospechar en este paciente es una retinopatía del prematuro o, lo que es lo mismo, una fibroplasia retrolental. Este trastorno consiste en una proliferación fibrovascular de la retina periférica debido al uso de oxigenoterapia en recién nacidos de bajo peso.

-----O-----

Ante una cirugía de catarata en la que la pupila dilata mal y el iris tiende a prolapsarse en las incisiones, hemos de sospechar que el paciente ha estado en tratamiento con:

1. Corticoides.
2. Tratamiento para la hiperplasia prostática benigna.
3. Tratamiento de asma bronquial.
4. Amiodarona.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos (tamsulosina, alfuzosina, doxazosina, prazosina) tienen como indicación principal el tratamiento de los síntomas asociados a la hiperplasia benigna de próstata, y doxazosina, además está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Durante la cirugía de cataratas, en algunos pacientes que están en tratamiento o han sido tratados previamente con bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, se ha observado un síndrome quirúrgico denominado “Síndrome del Iris Flácido Intraoperatorio”. Las consecuencias principales son complicaciones de la cirugía. Este síndrome consiste en miosis intraoperatoria

progresiva, a pesar de la dilatación preoperatoria con fármacos midriáticos de uso común, y potencial prolapso del iris hacia las incisiones de la facoemulsificación. Aunque el síndrome de iris flácido intraoperatorio se ha relacionado con todos estos fármacos y también con fármacos de otros grupos, la asociación es especialmente intensa con la tamsulosina. La tamsulosina es el fármaco que produce esta complicación con más frecuencia y que da lugar a las formas más severas.

-----O-----

Una hemianopsia altitudinal unilateral en el campo visual es MUY característica de:

1. Neuropatía óptica isquémica.
2. Glaucoma crónico simple muy evolucionado.
3. Glaucoma agudo de ángulo estrecho.
4. Desprendimiento de retina.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los defectos altitudinales son muy sugestivos de las neuropatías ópticas isquémicas. En este caso, el defecto campimétrico se debe al infarto de una parte del nervio óptico. En el glaucoma crónico, en fases muy avanzadas, se produce una pérdida casi total del campo visual, quedando solo conservados un islote central y uno temporal. En el glaucoma agudo también se van a producir defectos, pero que no guardan una topografía tan clara como en el glaucoma crónico. En el caso del desprendimiento de retina, podría producirse una hemianopsia altitudinal si se desprendiese la mitad inferior de la retina, pero el enunciado nos pide que señalemos la enfermedad de la que esto es muy característico, por lo que es preferible la opción de respuesta 1, ya que el desprendimiento de retina podría afectar a cualquier otra parte de esta, por lo que ya no sería el “defecto típico”, al haber otras muchas posibilidades (respuesta 1 correcta).

-----O-----

Cual de las siguientes afirmaciones acerca de la catarata es incorrecta

1. Para visualizar correctamente la catarata es preciso explorar el ojo dilatado con lámpara de hendidura con técnicas de iluminación directa y de retroiluminación.
2. Para la planificación de la cirugía es importante tener en cuenta el grado de dilatación de la pupila, la densidad de la catarata y la presencia o ausencia de síndrome de pseudoexfoliación, facodonesis o de cornea guttata.
3. La ecografía es una prueba complementaria que puede emplearse si el cristalino está muy opacificado para descartar patología del segmento posterior.
4. No es necesario realizar la anamnesis al paciente sobre los fármacos que toma ya que no influyen en el desarrollo de la cirugía.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La anamnesis acerca de los fármacos que toma el paciente es relevante antes de la cirugía de catarata, sobretodo conocer la medicación empleada para la retención urinaria ya que guarda una relación estrecha con el síndrome del iris flácido intraoperatorio.

-----O-----

Señale cuál de los siguientes signos NO es característico de DMAE exudativa:

1. Hemorragia subretiniana.

2. Membrana neovascular.
3. Exudados duros.
4. Escotoma central.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta acerca de la forma menos frecuente pero más severa de la degeneración macular asociada a la edad, es decir, la forma húmeda. Lo típico de esta forma es la aparición de membranas neovasculares que consisten en formaciones de neovasos procedentes de la coroides. Se pueden ver como lesiones en la mácula con aspecto de mancha grisácea, hemorragia subretiniana que produce desprendimiento a nivel foveal, o desprendimiento seroso macular. Lo que no es típico de la DMAE exudativa son los exudados duros que sugieren una forma seca. El paciente con DMAE húmeda refiere importante pérdida de visión central con o sin metamorfopsias.

-----O-----

Con respecto a la fístula carotido-cavernosa una de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. Es típica la presencia de inyección ciliar.
2. La PIO suele estar disminuida en el ojo afecto porque la fístula roba sangre de ese ojo.
3. Es típica la paresia de VI nervio craneal. Ello se debe a que este nervio circula muy próximo a la arteria carótida externa.
4. Esta es una de las pocas ocasiones en las que el oftalmólogo “desempolva” su fonendo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La fístula carotido-cavernosa es una entidad rara, pero por su rica semiología muy preguntable. Recuerda que produce una inyección en cabeza de medusa (opción 1 incorrecta), que el aumento de presión episcleral produce en estos pacientes un aumento de PIO (opción 2 incorrecta) y que el nervio más frecuentemente afectado es el VI, pero por su proximidad a la arteria carótida interna y no externa (opción 3 incorrecta). La opción 4 es la correcta porque en ocasiones es posible auscultar un soplo en la cabeza del paciente.

-----O-----

Con respecto a la retinopatía de la prematuridad. Señale la respuesta FALSA:

1. Los factores mas importantes para su desarrollo son el peso al nacer, la inmadurez vascular y la exposición a altas concentraciones de oxígeno.
2. Es una patología más común en países pobres que en países ricos.
3. Todos los recién nacidos menores a 34 semanas o 1500 gr deben realizar screening.
4. Para el screening habrá que realizar dilatación ocular con cicloplejico diluido.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El máximo riesgo se produce en los nacidos antes de la semana 34 y menores a 1500 gr de peso. Estos pacientes, en países subdesarrollados no suelen sobrevivir por lo que se trata de una patología muy poco frecuente en estos países. El peso al nacer, la madurez vascular y la exposición a concentraciones altas de oxígeno son los factores de riesgo mas importantes.

Respecto a la miopía en la infancia señale la afirmación falsa

1. Un niño con miopía debe llevar corrección óptica (gafas o lentes de contacto) para poder realizar un buen desarrollo visual
2. La atropina tópica a bajas concentraciones ha demostrado ser eficaz como tratamiento para frenar la progresión de la miopía en niños
3. La preocupación por el incremento en la prevalencia de la miopía en niños, en especial la miopía magna, se basa en los riesgos y costes derivados de las complicaciones asociadas que pueden ser causa de baja visión, ya que los pacientes miopes tienen más riesgo de desarrollar cataratas, glaucoma, estrabismo y patología retiniana
4. La miopía no necesita corrección óptica en niños hasta que no han cumplido la mayoría de edad

Resp. Correcta: 4

Comentario: La miopía es un defecto refractivo en el que se perciben las imágenes lejanas desenfocadas. Requiere corrección óptica con lentes divergentes (-). Los niños deben llevar los defectos de refracción corregidos en gafa o lente de contacto ya que en menores de 10 años se encuentran en el periodo de desarrollo visual

Una de las siguientes relaciones acerca de la irrigación ocular es INCORRECTA, señálela:

1. Arteria central de la retina-capas internas de la retina.
2. Arteria ciliar anterior-Iris.
3. Arteria ciliar posterior larga-Papila.
4. Arteria ciliar posterior corta-Coroides.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las arterias de las opciones 1 a 4 son ramas de la oftálmica, primera rama de la carótida interna. El territorio orbitario depende de ella. El segmento anterior del globo (iris, cuerpo ciliar...) depende de las arterias ciliares anteriores y posteriores largas. El nervio óptico y la coroides dependen de las arterias ciliares posteriores cortas, mientras que las capas más internas de la retina dependen de la arteria central de la retina. Las dos capas más externas de la retina en cambio dependen de la difusión desde la coroides, y por lo tanto de las ciliares posteriores cortas.

¿Cuál de los siguientes síntomas NO suele aparecer en la catarata senil?

1. Miopía.
2. Fotofobia.
3. Hipermetropía.
4. Leucocoria.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La catarata senil puede debutar con todos los siguiente síntomas excepto la hipermetropía (marcamos la opción de respuesta 3), ya que la catarata senil conlleva en todo caso miopía porque aumenta el índice de refracción del cristalino (el paciente ve mejor de cerca).

-----O-----

Varón de 75 años que acude a Urgencias con ojo rojo doloroso de 3 días de evolución, con visión borrosa, secreciones, inyección periquerática y una mancha blanquecina en el espesor de la córnea paracentral, redondeada, que tiñe con fluoresceína. Tiene cierto grado de miosis reactiva y células en cámara anterior. ¿De qué proceso se trata?

1. Conjuntivitis bacteriana aguda.
2. Queratitis herpética.
3. Absceso corneal bacteriano.
4. Leucoma corneal.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Se trata de un caso de ojo rojo doloroso. Las conjuntivitis no duelen. Los leucomas son cicatrices blanquecinas en la córnea pero no se asocian a ojo rojo. Las queratitis herpéticas cursan con ojo rojo doloroso y la córnea tiñe con forma de dendrita o de úlcera geográfica pero no como mancha blanquecina. Así que sólo queda el absceso bacteriano, que se asocia a la presencia de células en cámara anterior, es decir Tyndall, cuando el absceso es severo.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes patologías cursa con leucocoria?:

1. Queratocono.
2. Retinopatía de la prematuridad.
3. Glaucoma congénito.
4. Coloboma de iris.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Esta pregunta no debes fallarla. El diagnóstico diferencial de la leucocoria en edad infantil es un tema muy preguntado y por lo tanto muy rentable. Se define como leucocoria la presencia de un reflejo pupilar blanco. Otras causas de leucocoria son la catarata congénita (la más frecuente), retinoblastoma, persistencia del vitreo primario hiperplásico, Toxocariasis ocular y la Enfermedad de Coats.

-----O-----